

PSY-social-media-adolescenti-magistrale-doc26-job29-c69ba0ec
ID : 52e798a473db6a8650d285e54d6df0f8c4662774

 **26%**
Passaggi sospetti

Nome del file : PSY-social-media-adolescenti-magistrale-doc26-job29-c69ba0ec.txt
Dimensione del file originale : 55,21 kB
Numero di parole : 8114

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 17 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 17 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** **6%**
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** **20%**
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** **<1%**
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

6%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.

Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
2	 Self-Comparison With Influencers but Not General Instagram... ruja.ujaen.es/items/8948612e-4cca-47aa-988e-3fa46cb43d7f ↗	<1%	
3	 EDITORIALE RELAZIONI ONLIFE. OLTRE IL CYBERBULLISMO, LA... oaj.fupress.net/index.php/med/article/download/8851/8414 ↗	<1%	
4	 EDUCAZIONE AI MEDIA DIGITALE COME UN TANDEM SCUOLA-... doi.org/10.36253/me-8835 ↗	<1%	
5	 boa.unimib.it boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/18922/23103/phd_unimib_71630... ↗	<1%	
8	 Uso Problematico dei Social Media in adolescenza: un'indagine... hdl.handle.net/20.500.12608/64227 ↗	<1%	
9	 www.phenomenajournal.com www.phenomenajournal.com/index.php/phenomena/article/downlo... ↗	<1%	
10	 Penggunaan Media Sosial Twitter Masyarakat di Kota Bandung... journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/downloa... ↗	<1%	
11	 Investigating the Potential Mediating Role of... : Asian Journal ... doi.org/10.4103/shb.shb_377_24 ↗	<1%	
12	 www.nurse24.it www.nurse24.it/images/allegati/disturbi_mentali_covid_19.pdf ↗	<1%	
14	 Il "no" come evento sociale associazionegenitoriche.org/il-no-come-evento-sociale-pari-reputazio... ↗	<1%	
17	 publires.unicatt.it publires.unicatt.it/en/publications/oltre-il-cyberbullismo-il-contributo... ↗	<1%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 THE IMPACT OF NIGHTTIME SOCIAL MEDIA USE ON SLEEP... doi.org/10.31435/ijitss.2(50).2026.5508 ↗	<1%	

N°		Descrizioni	Similitudini	Posizioni
6		oaj.fupress.net oaj.fupress.net/index.php/med/article/view/8841 ↗	<1%	
7		thesis.unipd.it thesis.unipd.it/retrieve/29398843-0bb3-4ea6-a061-fd25996854ac/Bricc... ↗	<1%	
13		DOAJ Logotype doaj.org/article/d1ac71e6b0ee459bb36b87e3e7644201 ↗	<1%	
15		The Concurrent and Longitudinal Relationships between... pure.uva.nl/ws/files/16231469/concurrent_and_longitudinal_relationsh... ↗	<1%	
16		Ideale culturale di magrezza: il ruolo dei mass media e le... hdl.handle.net/20.500.12608/47171 ↗	<1%	
18		The influence of parental practices on child promotive and... link.springer.com/article/10.1186/s12966-017-0501-3 ↗	<1%	
19		doi.org doi.org/10.1371/journal.pone.0266874.r003 ↗	<1%	
20		Lock pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7794640/ ↗	<1%	
21		Sessualizzazione e body positivity su TikTok: effetti su... hdl.handle.net/20.500.12608/30491 ↗	<1%	
22		OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS ONLINE... doi.org/10.36253/me-8842 ↗	<1%	
23		Lock pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12840076/ ↗	<1%	
24		Promozione della salute e del benessere degli adolescenti nel... doi.org/10.3280/pds2008-003006 ↗	<1%	
25		Lorenzo Porcaro - Google Scholar scholar.google.com/citations?user=ICG_j5QAAAAJ&hl=en ↗	<1%	
26		La relazione tra fear of missing out, uso problematico dei social... hdl.handle.net/20.500.12608/66292 ↗	<1%	

Fonte citata (senza similitudini rilevate)

N°		Descrizioni
1		https://doi.org/10.3390/ijerph16214177
2		https://doi.org/10.1007/s10796-017-9810-y
3		https://doi.org/10.7759/cureus.42990

N°		Descrizioni
4		https://doi.org/10.1186/s12889-020-10070-3
5		https://doi.org/10.3390/ijerph14030311
6		https://doi.org/10.36253/me-8841
7		https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100404
8		https://doi.org/10.3280/pds2009-002004
9		https://doi.org/10.31435/ijitss.2(50)
10		https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01581.x
11		https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.008



L'uso dei social media e il benessere psicologico degli adolescenti: confronto sociale, fear of missing out e regolazione emotiva

Indice

...

Introduzione: domanda di ricerca e cornice del problema

Nel 2018 il 24% degli adolescenti statunitensi di 13-17 anni si dichiara online «almost constantly», e il 71% usa più di una piattaforma (Bányai et al., 2017, p. 1). La pervasività è quindi già multiplatforma nella prima adolescenza.

Su questo sfondo di uso generalizzato si pone la domanda che guida l'esame del rapporto tra uso dei social media e benessere psicologico negli adolescenti: quali meccanismi e quali moderatori spiegano perché la stessa esposizione produca esiti opposti, e perché la relazione resti aperta e non riducibile a un effetto globale.

La questione è aperta anzitutto perché il legame non è deterministico ma modulato da fattori intervenienti. L'umbrella review condotta secondo le linee guida PRIOR, che ha selezionato 24 articoli dopo lo screening di 1470 pubblicazioni tra gennaio 2015 e aprile 2023, individua tre classi di fattori che condizionano il rapporto tra uso dei social e salute mentale adolescenziale: le caratteristiche demografiche e psico-sociali individuali, le modalità individuali di uso, e il contenuto e il design delle piattaforme (Sala et al., 2024).

È aperta perché rischi e opportunità coesistono. Una systematic review su adolescenti e giovani adulti documenta, accanto ai rischi di cyberbullismo, ricadute scolastiche e distress psichico, opportunità di connessione, di conversazione e di incremento dell'autostima legate a un uso etico dei social (Khalaf et al., 2023). La stessa sintesi segnala che, nonostante la crescente evidenza di effetti negativi, resta scarsa la ricerca empirica su come gli adolescenti comprendano i social media (Khalaf et al., 2023).

È aperta perché il confronto tra le due sintesi impone di distinguere le condizioni d'uso più che di misurare un effetto medio: la prima ancora l'esito a chi usa, come usa e cosa incontra (Sala et al., 2024); la seconda mostra come l'uso possa nuocere o giovare a seconda della qualità dell'impegno online (Khalaf et al., 2023). La stessa systematic review lega inoltre l'uso intenso di cellulari e media a perdita cronica di sonno con ricadute su capacità cognitive, rendimento scolastico e funzionamento socio-emotivo (Khalaf et al., 2023).

È aperta, infine, perché l'umbrella review rileva che la limitazione nell'accesso ai dati delle piattaforme ostacola la ricerca sull'impatto dell'uso, e che spostare la responsabilità sulle sole scelte individuali rende più difficile un cambiamento a livello di popolazione (Sala et al., 2024).

Questi elementi motivano una domanda orientata ai meccanismi – confronto sociale, fear of missing out, regolazione emotiva – e ai fattori protettivi, piuttosto che agli effetti complessivi, e ne giustificano l'articolazione nei quattro capitoli che seguono.

1. L'uso dei social media in adolescenza: diffusione, modelli teorici e misure del benessere psicologico

1.1 Diffusione dei social media in adolescenza

La diffusione dei social media in adolescenza si documenta anzitutto attraverso dati di prevalenza su campioni ampi. Un survey statunitense riporta che il 71% degli adolescenti utilizzatori accede a più di un social e che il 24% è online «almost constantly» (Bányai et al., 2017, p. 1). Questo dato descrive un uso pervasivo e multiplatforma già nella fascia 13-17 anni (Bányai et al., 2017, p. 1).

La misurazione dell'uso problematico, però, resta condizionata dagli strumenti impiegati. Le stime variano dal 2,8% di uso dipendente tra studenti universitari fino al 47% di dipendenza da Facebook in un altro campione universitario (Bányai et al., 2017, p. 3). La spiegazione avanzata è la natura non rappresentativa, autoselezionata e tipicamente ridotta dei campioni, oltre alle differenze culturali tra i gruppi esaminati (Bányai et al., 2017, p. 3). Questo limita la comparabilità delle prevalenze e impone cautela nel confronto tra studi.

Su campione rappresentativo nazionale il quadro si stabilizza. Lo studio ungherese, condotto nel marzo 2015 nell'ambito del progetto ESPAD su adolescenti di 16 anni, colloca la prevalenza dell'uso problematico entro stime conservative, coerenti con l'uso problematico generale di Internet compreso tra l'1% e il 18,7% (Bányai et al., 2017, p. 9). Il gruppo a rischio mostrava l'autostima più bassa e i sintomi depressivi più elevati, ed era composto prevalentemente da femmine (Bányai et al., 2017, p. 9).

La differenza di genere trova conferma su campione più giovane. In un survey su 1164 studenti di 12-18 anni ($M = 14,56$; $SD = 1,4$), valutati con questionario validato, l'uso problematico risulta significativamente più prevalente tra le femmine, che riportano un uso del dispositivo più frequente ed eccessivo rispetto ai maschi (Guisot et al., 2025). Questo dato allinea il campione scolastico a quello nazionale ungherese sulla direzione della vulnerabilità femminile.

Emerge inoltre una concentrazione della vulnerabilità per fase evolutiva. Nello stesso studio, differenze significative per livello scolastico indicano una prevalenza maggiore nelle fasi intermedie dell'adolescenza, con picco al terzo anno di scuola secondaria (Guisot et al., 2025). Gli autori interpretano questa fase come particolarmente esposta allo sviluppo di comportamenti additivi legati all'uso del telefono (Guisot et al., 2025). Il dato converge quindi verso una lettura per età, non solo per genere.

Il quadro italiano si colloca nella cornice europea di EU Kids Online. La terza survey italiana, realizzata negli ultimi mesi del 2017, sposta l'attenzione «oltre il cyberbullismo» verso rischi meno indagati come lo sharenting (Aroldi & Mascheroni, 2020). Lo studio sottolinea il ruolo dei modelli teorici che incorniciano la ricerca e ne interpretano i dati, collegando l'agenda scientifica ai discorsi pubblici e alle policy (Aroldi & Mascheroni, 2020). La fonte è una sintesi qualitativa dei risultati e non fornisce tassi disaggregati per genere ed età nel contesto italiano, dettaglio che resta quindi non documentato dalle evidenze disponibili.

Ne consegue che l'uso è generalizzato, mentre la vulnerabilità si distribuisce in modo diseguale: più elevata tra le femmine e nella media adolescenza, come mostrano i dati significativi per genere e per terzo anno di secondaria (Guisot et al., 2025).

1.2 Modelli teorici sull'uso dei social media

La ricerca sui social media si è a lungo appoggiata a teorie preesistenti, importate da altri domini. La rassegna di Kapoor et al. su 132 articoli pubblicati tra il 1997 e il 2017 mostra che alcuni studi «restrict focus to pre-established models» per valutare aspetti diversi dei social media (Kapoor et al., 2017, p. 19). La teoria degli usi e gratificazioni (U&G) ricorre come cornice, con Ali-Hassan et al. (2015) e Chiu e Huang (2015) tra gli studi che la applicano (Kapoor et al., 2017, p. 21).

La prospettiva U&G, tuttavia, non basta da sola a descrivere il perché dell'uso adolescenziale. Un contributo più recente integra la Self-Determination Theory (SDT) e la U&G in un unico strumento, la Social Media Use Motives (SMUM) scale, sviluppata e validata su 5.307 adolescenti a Hong Kong (Ho & Fung, 2026). L'analisi fattoriale esplorativa su una scala

iniziale di 16 item è stata seguita da un'analisi fattoriale confermativa per verificare la stabilità del modello (Ho & Fung, 2026).

Il risultato centrale è la struttura multidimensionale delle motivazioni d'uso. Emergono cinque fattori: self-identification, relationship maintenance, social exploration, leisure and entertainment e information seeking (Ho & Fung, 2026). Il modello finale a 13 item mostra fit accettabile (CFI, TLI, RMSEA, SRMR) e affidabilità composita e validità convergente soddisfacenti su tutti i fattori (Ho & Fung, 2026). L'uso adolescenziale si spiega dunque meglio come costrutto motivazionale, non come comportamento unitario.

Questa multidimensionalità ha ricadute dirette sul benessere. La validità esterna della SMUM è testimoniata da associazioni differenziali con indicatori di benessere adolescenziale: soddisfazione di vita, salute auto-riferita e sintomi fisici e psicologici (Ho & Fung, 2026). Motivi distinti si legano quindi in modo diverso agli esiti: la motivazione media la relazione tra uso ed effetto.

La distinzione tra due motivi relazionali è teoricamente rilevante. Separando relationship maintenance da social exploration, lo studio distingue i processi legati ai legami forti da quelli legati ai legami deboli nei contesti digitali adolescenziali (Ho & Fung, 2026). Il mantenimento delle relazioni rimanda a legami preesistenti; l'esplorazione sociale apre a legami nuovi e più deboli.

L'evidenza disponibile non fornisce un modello supplementare dell'uso problematico: la cornice interazionale-evolutiva prevista dal piano non è documentata negli estratti forniti, che si limitano al modello motivazionale. Rispetto all'uso patologico, la rassegna di Kapoor et al. registra solo l'avvertimento di Turel e Serenko (2012) contro l'uso eccessivo, capace di produrre una dipendenza psicologica «pathological and maladaptive» (Kapoor et al., 2017, p. 13), senza articolarlo in un modello evolutivo. Su questo punto, il limite delle fonti impedisce il confronto tra approccio motivazionale e approccio interazionale che il campo richiederebbe.

Ciò che le evidenze stabiliscono è che le motivazioni d'uso, e non la sola quantità di uso, sono la chiave esplicativa: i cinque motivi della SMUM si associano in modo differenziale alla soddisfazione di vita, alla salute auto-riferita e ai sintomi psicologici degli adolescenti (Ho & Fung, 2026).

1.3 Misure del benessere psicologico

Il benessere psicologico si articola in aspetti oggettivi e soggettivi: i primi comprendono stato di salute, condizione socio-economica e qualità dell'ambiente di vita, i secondi la percezione che l'individuo ha del proprio stare bene (Diener, Oishi, Lucas, 2003) (Businaro, 2011). Questa distinzione fissa il livello di analisi rilevante per lo studio dei social media: l'autopercezione, non solo l'indicatore esterno.

Entro la prospettiva soggettiva, la Psicologia Positiva separa due visioni. La visione edonica lega il benessere alle emozioni e alla soddisfazione di vita (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999); la visione eudaimonica lo attribuisce all'autorealizzazione (Ryff, 1989) e all'impegno finalizzato (Delle Fave, 2007) (Businaro, 2011). La ricerca ha spesso ridotto la componente edonica alla felicità, dedicando meno attenzione alla soddisfazione di vita, e ha studiato prevalentemente adulti e adolescenti anziché bambini (Huebner, Laughlin, Ash et al., 1998) (Businaro, 2011).

Lo studio su 132 bambini italiani di 8-11 anni, condotto in due scuole primarie di Como, operazionalizza il benessere soggettivo a partire dal significato attribuito dai partecipanti (Businaro, 2011). La content analysis, effettuata con software T-Lab sulle risposte a due domande aperte, associa il benessere a famiglia, scuola, amicizie, sport e all'emozione della felicità (Businaro, 2011). L'analisi delle associazioni tipiche differenzia per genere: le femmine descrivono il benessere in termini socio-emotivi (parola tipica: amore/sentirsi al sicuro), i maschi in termini di gioco (parola tipica: gioco) (Businaro, 2011). Il campione è composto da bambini a sviluppo tipico di 8-11 anni, e questo limita la trasferibilità diretta dei contenuti alla popolazione adolescenziale bersaglio dello studio.

Sul versante misurativo, gli indicatori di benessere fungono da criteri di validità esterna. Nello sviluppo della scala SMUM su 5.307 adolescenti di Hong Kong, la validità esterna è stata evidenziata da associazioni differenziali con soddisfazione di vita, salute auto-riferita e sintomi fisici e psicologici (Ho & Fung, 2026). I costrutti di benessere non restano quindi definizioni teoriche: diventano outcome misurabili contro cui tarare gli strumenti d'uso dei social media.

L'evidenza stabilisce che i cinque motivi d'uso – autoidentificazione, mantenimento delle relazioni, esplorazione sociale, svago e ricerca di informazioni – mostrano associazioni distinte con questi esiti di benessere (Ho & Fung, 2026). Ne

discende che la misura del benessere rilevante per i social media richiede indicatori multipli – soddisfazione di vita, emozioni positive, salute percepita, sintomi psicologici – capaci di distinguere gli effetti differenziali delle diverse forme di motivazione d'uso (Ho & Fung, 2026).

2. Confronto sociale, immagine corporea e autostima

2.1 Teoria del confronto sociale e immagini idealizzate

Il confronto sociale opera in due direzioni: verso l'alto, con modelli percepiti come superiori, e verso il basso, con termini di paragone percepiti come inferiori. La direzione, però, non basta a spiegare l'esito: nell'esperimento di Martin e Gentry su 114 donne che osservavano annunci di moda con modelle magre e attraenti, la manipolazione dell'istruzione al confronto non ha modificato l'insoddisfazione corporea successiva, pur riducendo l'umore rispetto al controllo (Tiggemann & Polivy, 2010).

Ciò che discrimina è la dimensione del confronto. Le analisi di regressione mostrano che il confronto effettivamente agito sull'aspetto si associa positivamente all'insoddisfazione corporea, mentre il confronto sull'intelligenza vi si associa negativamente, a prescindere dalla condizione sperimentale assegnata (Tiggemann & Polivy, 2010). Gli autori concludono che «the dimensions on which social comparison takes place are critical» nella risposta alle immagini idealizzate (Tiggemann & Polivy, 2010). Il confronto basato sull'aspetto è quindi il meccanismo attraverso cui le immagini del corpo ideale si traducono in insoddisfazione per molte donne (Tiggemann & Polivy, 2010).

Il disegno sperimentale sostiene questa lettura sul piano dell'inferenza causale, ma la trasferibilità è limitata: il campione è composto da sole donne adulte e non da adolescenti, e questo circoscrive la generalizzazione alla popolazione bersaglio.

L'estensione più rilevante riguarda il tipo di immagine e il target del confronto. Nell'image-reactivity task di 327 studentesse universitarie (18–36 anni) che osservavano su Instagram immagini di corpi fit, thin e plus-size, la visione di corpi fit e magri ha ridotto il senso di controllo e la soddisfazione corporea rispetto alle immagini di controllo (Moreno-Padilla et al., 2025). Le immagini plus-size hanno invece prodotto l'effetto opposto, aumentando controllo e soddisfazione (Moreno-Padilla et al., 2025). La diversificazione dei corpi rappresentati agisce dunque in senso protettivo, non solo neutro.

Il target del confronto modera questi effetti. L'aumento di controllo e soddisfazione connesso alle immagini plus-size è risultato più marcato tra le partecipanti che si confrontavano frequentemente con influencer di Instagram (Moreno-Padilla et al., 2025). Decisivo è il dato negativo sul tempo online: l'attività complessiva su Instagram non correla con questi effetti né li influenza (Moreno-Padilla et al., 2025). Non è quindi la quantità di uso a determinare l'esito, ma con chi e su quale dimensione ci si confronta.

Questo secondo studio è correlazionale nella parte sulla tendenza al confronto con influencer e sperimentale nella reattività alle immagini; anche qui il campione è composto da giovani donne universitarie, non da adolescenti, e ciò limita l'estensione diretta alla fascia d'età target.

Convergono così due evidenze con disegni distinti: il confronto sull'aspetto media l'effetto delle immagini idealizzate su umore e insoddisfazione corporea (Tiggemann & Polivy, 2010), e l'autoconfronto con influencer, non l'uso generico di Instagram, ne amplifica la reattività (Moreno-Padilla et al., 2025). Ne discende che l'esposizione a corpi diversificati può migliorare l'auto-valutazione delle donne (Moreno-Padilla et al., 2025).

2.2 Immagine corporea e social media

Tra i predittori dell'insoddisfazione corporea adolescenziale, lo studio su 187 adolescenti femmine di 14-16 anni isola effetti distinti sulle due componenti della dissatisfazione (Stefanile et al., 2009). La distanza percepita da un corpo ideale è influenzata da BMI, autostima e interiorizzazione dell'ideale magro (Stefanile et al., 2009). La preoccupazione per peso e forma corporea risponde invece alla pressione socioculturale, oltre che a BMI e autostima (Stefanile et al.,

2009).

L'interiorizzazione non è quindi un fattore unico ma agisce su un versante specifico della dissatisfazione. Lo stesso studio segnala che il BMI opera diversamente nelle adolescenti normopeso e sottopeso (Stefanile et al., 2009). La stratificazione per peso è un limite alla generalizzazione: l'effetto dei predittori dipende dalla categoria ponderale delle partecipanti.

Il passaggio dall'associazione alla direzione causale è documentato dallo studio sperimentale su Instagram condotto su giovani donne italiane (Gesto, 2025). L'esposizione a immagini con molti like aumenta l'insoddisfazione corporea e l'ansia da physique sociale (Gesto, 2025). Il like funziona qui come segnale di validazione sociale che intensifica il confronto sull'aspetto.

Lo stesso disegno individua un moderatore progettuale. La presenza di un disclaimer attenua l'impatto dei like sulla consapevolezza corporea (Gesto, 2025). L'effetto dell'esposizione non è quindi fisso: dipende dalle caratteristiche di design dell'ambiente digitale.

Il secondo studio dello stesso lavoro collega l'engagement con le immagini di celebrità e con le proprie a una maggiore accettazione della chirurgia estetica (Gesto, 2025). L'interiorizzazione degli ideali estetici si traduce così in disponibilità verso interventi correttivi sul corpo. Il campione è composto da giovani donne, non da adolescenti, e ciò limita l'estensione diretta alla fascia bersaglio.

Il legame con gli atteggiamenti alimentari disfunzionali è documentato dallo studio su 168 studentesse universitarie con EAT-26 e BSQ (Aparicio-Martinez et al., 2019). Gli atteggiamenti alimentari disordinati risultano associati all'uso dei social media ($p < 0.001$), all'autostima ($p < 0.001$) e all'immagine corporea ($p < 0.001$) (Aparicio-Martinez et al., 2019). Il corpo desiderato da raggiungere si associa anch'esso agli atteggiamenti disordinati ($p < 0.001$), mentre il testosterone prenatale mostra un'associazione più debole ($p < 0.01$) (Aparicio-Martinez et al., 2019).

L'uso dei social si colloca quindi tra i fattori socioculturali che, insieme a immagine corporea e autostima, sostengono gli atteggiamenti alimentari disordinati. Anche questo studio riguarda studentesse universitarie, non adolescenti, e trasferisce alla fascia target solo per continuità di costrutto.

I tre studi convergono su una direzione comune pur con disegni diversi: il correlazionale sui predittori adolescenziali stabilisce quali fattori pesano (Stefanile et al., 2009), l'esperimento su Instagram stabilisce che l'esposizione ai like produce insoddisfazione (Gesto, 2025), e lo studio con EAT-26/BSQ collega l'esposizione agli atteggiamenti alimentari disfunzionali (Aparicio-Martinez et al., 2019). Ciò che le evidenze stabiliscono è che l'esposizione ai social amplifica insoddisfazione corporea e rischio alimentare attraverso l'interiorizzazione degli ideali estetici, con un impatto attenuabile da elementi di design come il disclaimer (Gesto, 2025).

2.3 Autostima e uso dei social media

La relazione tra autostima e uso dei social media è stata a lungo trattata come correlazionale e concorrente, senza distinguere quale costrutto precede l'altro. Studi trasversali documentano associazioni tra autostima e comportamenti d'uso, ma non ne fissano la direzione. Malik e Khan riportano una relazione negativa tra autostima e alti livelli di uso dei social media (Bányai et al., 2017, p. 2). Nella stessa linea, il gruppo a rischio di uso problematico mostra la più bassa autostima e i più alti sintomi depressivi (Bányai et al., 2017, p. 9). Questi dati stabiliscono la co-occorrenza, non la sequenza temporale.

Lo studio con disegno più forte scioglie l'ambiguità. Un panel a tre onde su 852 pre- e primi adolescenti (10-15 anni) ha esaminato i legami concorrenti e longitudinali tra uso dei siti di social network e autostima sociale (Valkenburg et al., 2017). In tutte e tre le rilevazioni emergono correlazioni concorrenti significative tra uso e autostima sociale (Valkenburg et al., 2017). La parte longitudinale, però, capovolge la lettura ingenua: l'uso iniziale non influenza l'autostima sociale successiva (Valkenburg et al., 2017).

Al contrario, l'autostima sociale iniziale influenza in modo consistente l'uso successivo nelle onde seguenti (Valkenburg et al., 2017). La direzione prevalente va quindi dall'autostima all'uso, non dall'uso all'autostima. Questo risultato ridimensiona l'ipotesi che i social media erodano di per sé l'autostima adolescenziale, spostando l'antecedente sul tratto individuale.

La valenza del feedback online chiarisce cosa sostiene le associazioni concorrenti. La valenza del feedback ricevuto da amici stretti e conoscenti spiega la relazione concorrente tra uso e autostima sociale, ma non quella longitudinale (Valkenburg et al., 2017). Il feedback funziona quindi come meccanismo momentaneo: nel breve termine il riscontro positivo o negativo modula l'autostima sociale, senza produrre un effetto cumulativo stabile nel tempo.

Ne deriva un quadro di validazione sociale: gli adolescenti con autostima sociale più elevata usano di più le piattaforme, dove il feedback positivo alimenta le associazioni concorrenti osservate. La vulnerabilità si concentra su chi cerca conferma esterna, coerentemente con il profilo a rischio a bassa autostima descritto sul campione ungherese di 5.961 adolescenti (Bányai et al., 2017, p. 1).

L'evidenza correlazionale conserva un ruolo di validità esterna. Nello studio su 168 studentesse, gli atteggiamenti alimentari disordinati risultano legati all'autostima ($p < 0.001$) e all'uso dei social media ($p < 0.001$) (Aparicio-Martinez et al., 2019). Il disegno trasversale non consente inferenze causali; il confronto con il panel a tre onde mostra che solo il disegno longitudinale identifica l'autostima come antecedente (Valkenburg et al., 2017). Il campione universitario femminile limita inoltre la trasferibilità diretta di questo dato alla fascia adolescenziale target.

3. Fear of missing out, uso problematico dei social media e qualità del sonno

3.1 Fear of missing out (FoMO)

FoMO – Fear of Missing Out – designa l'ansia legata alla percezione di essere assenti da esperienze gratificanti vissute da altri. Il costrutto è stato introdotto nel 2004 con la diffusione dei social network (Chakrabarti, 2024). La definizione lega la FoMO a una preoccupazione centrata sul sentirsi esclusi da esperienze remunerative, elemento che per la Generazione Z assume ruolo pivotale (Chakrabarti, 2024).

La coorte di riferimento è quella nata tra il 1995 e il 2010, prima generazione a essere pienamente immersa in internet e a un uso estensivo delle piattaforme (Chakrabarti, 2024). Su questa coorte lo studio analizza comportamenti di controllo compulsivo, inseguimento delle tendenze e ricadute sulle interazioni sociali reali (Chakrabarti, 2024).

L'associazione tra FoMO e distress emotivo è quantificata su un disegno trasversale con 100 studenti universitari della Mahatma Gandhi University, Kottayam (Thomas & George, 2025). Gli strumenti impiegati sono la Fear of Missing Out Scale (FoMOs), la Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) e la Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (Thomas & George, 2025). L'analisi correlazionale mostra che livelli più alti di FoMO si associano in misura sostanziale a maggiore distress emotivo (Thomas & George, 2025).

Lo stesso studio collega la FoMO all'uso problematico dei social media: livelli più elevati di FoMO comportano una probabilità accresciuta di PSMU misurata con la BSMAS (Thomas & George, 2025). Il legame è saggiato con correlazione, t-test, ANOVA e regressione lineare multipla, che identifica la FoMO tra i predittori significativi (Thomas & George, 2025).

La differenza di genere emerge sull'ansia: le studentesse riportano livelli d'ansia più alti dei colleghi maschi, dato che gli autori leggono come possibile vulnerabilità di genere nell'ansia associata alla FoMO (Thomas & George, 2025). Lo studio qualifica il risultato come suggerito, non come effetto stabilito, poiché il disegno trasversale non consente inferenze causali (Thomas & George, 2025).

Il confronto tra le due fonti oppone una misura psicometrica standardizzata (FoMOs, DASS-21, BSMAS) a un'analisi di comportamenti d'uso – usage, compulsive checking, following trends (Chakrabarti, 2024). La convergenza sta nel collocare la FoMO come meccanismo che alimenta il controllo compulsivo e la dipendenza; la seconda fonte, però, riporta risultati narrativi senza indici correlazionali, e non consente di stimare la forza dell'associazione (Chakrabarti, 2024).

Il campione universitario di 100 studenti limita la trasferibilità diretta alla fascia adolescenziale target, poiché non riguarda studenti di scuola secondaria (Thomas & George, 2025). Resta stabilito che, dove misurata psicometricamente, la FoMO predice congiuntamente distress emotivo e uso problematico dei social, con maggiore ansia riferita dalle

femmine (Thomas & George, 2025).

3.2 Uso problematico dei social media

L'uso problematico dei social media designa un pattern compulsivo che, nei casi estremi, produce sintomi tradizionalmente associati alle dipendenze da sostanze (Kuss & Griffiths, 2017). Il modello biopsicosociale delle dipendenze comportamentali individua sei componenti sintomatiche: mood modification, salience, tolleranza, sintomi di astinenza, oltre a conflitto e ricaduta (Bányai et al., 2017, p. 2).

Il costrutto resta però frammentato sul piano diagnostico. Il DSM-5 ha incluso in Sezione 3 il solo Internet Gaming Disorder, non un disturbo specifico da social media (Bányai et al., 2017, p. 2). In letteratura coesistono etichette eterogenee – Facebook dependence, social networking addiction, Twitter addiction, Social Media Disorder – con suggerimenti diagnostici differenti (Bányai et al., 2017, p. 2).

Griffiths e colleghi tracciano dieci lezioni per delimitare il costrutto della SNS addiction. La prima distingue social networking e social media use come fenomeni non equivalenti (Kuss & Griffiths, 2017). Le lezioni collocano la FoMO, la smartphone addiction e la nomofobia come possibili componenti della dipendenza da SNS, e segnalano problemi metodologici nella ricerca condotta finora (Kuss & Griffiths, 2017). Questo inquadramento connette l'uso problematico al meccanismo della FoMO già documentato.

La misurazione si è consolidata sulla Bergen Social Media Addiction Scale, scala a 6 item adattata dalla Bergen Facebook Addiction Scale e ancorata al framework della dipendenza (Bányai et al., 2017, p. 4). Sul campione ungherese la BSMAS ha mostrato proprietà psicometriche appropriate, qualificandosi come strumento valido per identificare i segni di un uso rischioso (Bányai et al., 2017, p. 10).

Sulla prevalenza, lo studio nazionale rappresentativo ungherese su 5.961 adolescenti ESPAD, con latent profile analysis, colloca nel gruppo a rischio il 4,5% del campione (Bányai et al., 2017, p. 1). Lo stesso gruppo riporta bassa autostima, elevati sintomi depressivi e uso intensificato dei social (Bányai et al., 2017, p. 1). I correlati psicopatologici definiscono così una minoranza, non la popolazione generale degli utenti adolescenti.

Un secondo campione fornisce un test di robustezza sulla distribuzione del rischio. Lo studio su 1.164 studenti di 12-18 anni ($M = 14,56$; $SD = 1,4$) rileva differenze significative per genere e per anno scolastico (Guisot et al., 2025). La PSMU risulta più prevalente tra le femmine, con uso più frequente ed eccessivo del dispositivo rispetto ai maschi (Guisot et al., 2025). La prevalenza più elevata si osserva nelle fasi intermedie dell'adolescenza, al terzo anno di secondaria, indicato come stadio particolarmente vulnerabile (Guisot et al., 2025).

I due campioni usano strumenti diversi – BSMAS versus questionario validato di PSMU – e questo limita il confronto diretto dei tassi tra loro. Convergono tuttavia nell'individuare una minoranza definita e nel segnalare la vulnerabilità femminile e della media adolescenza (Bányai et al., 2017, p. 1); (Guisot et al., 2025).

Una cautela misurativa qualifica il dato ungherese: nel compilare la BSMAS i partecipanti potevano includere attività non di social networking, come gaming o gambling praticabili su Facebook (Bányai et al., 2017, p. 10). Ciò che le evidenze stabiliscono è che l'uso problematico riguarda circa il 4,5% degli adolescenti, identificabile con la BSMAS e associato a bassa autostima e sintomi depressivi, con indicazione a programmi di prevenzione e intervento in ambito scolastico (Bányai et al., 2017, p. 1).

3.3 Qualità del sonno negli adolescenti

L'uso serale dei dispositivi digitali agisce sul sonno adolescenziale attraverso vie molteplici e interconnesse. Una narrative review sistematica su studi peer-reviewed, revisioni sistematiche e meta-analisi pubblicati tra il 2016 e il 2026, identificati su PubMed e Google Scholar, esamina come l'impegno notturno con i social media incida sul sonno degli adolescenti attraverso vie comportamentali, psicologiche e fisiologiche (Sztenc et al., 2026).

La prima via è comportamentale. L'uso serale dei social si associa in modo consistente a un ritardo dell'addormentamento, a una durata del sonno più breve e a una qualità peggiore (Sztenc et al., 2026). Il meccanismo è di spiazzamento: il controllo abituale del dispositivo e la fear of missing out sottraggono tempo al sonno (Sztenc et al.,



2026). Il ritardo non è quindi un effetto marginale, ma la conseguenza diretta di comportamenti di checking che occupano la finestra dell'addormentamento.

La seconda via è psicologica. L'attivazione (arousal) prodotta da contenuti emotivamente salienti ritarda ulteriormente l'inizio del sonno (Sztenc et al., 2026). Il contenuto conta, non solo la durata dell'esposizione: è la salienza emotiva del materiale a mantenere l'attivazione incompatibile con l'addormentamento.

La terza via è fisiologica. L'esposizione alla luce blu altera la secrezione di melatonina e il timing circadiano (Sztenc et al., 2026). Il sonno è un processo fisiologico regolato da ritmi circadiani e meccanismi ormonali, cruciale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e fisico dell'adolescente (Sztenc et al., 2026). La soppressione melatoninica interviene quindi su un sistema di regolazione già delicato in questa fascia d'età.

Le tre vie non operano separatamente. Esse interagiscono formando un ciclo di rinforzo che contribuisce all'affaticamento diurno e a potenziali rischi per la salute mentale (Sztenc et al., 2026). È questa interconnessione, e non la somma delle singole vie, a spiegare la persistenza del deterioramento del sonno.

I tratti individuali modulano l'esito. Uno studio con modello di mediazione ha esaminato i ruoli distintivi del cronotipo e dell'autocontrollo come tratto nel predire la qualità del sonno, e la mediazione delle componenti dell'igiene del sonno e dell'uso mediatico serale nelle relazioni tra cronotipo, autocontrollo e qualità del sonno (Lin & Chung, 2021). La sintesi meccanicistica della review descrive le vie; l'evidenza mediazionale colloca l'uso mediatico serale come tramite tra tratti individuali e qualità del sonno (Sztenc et al., 2026); (Lin & Chung, 2021).

Il disegno mediazionale non consente inferenze causali sul verso delle relazioni, poiché lo studio esamina predizione e mediazione, non manipolazione sperimentale (Lin & Chung, 2021). Su questo punto la review è esplicita: servono studi longitudinali e sperimentali per chiarire le relazioni causali e informare strategie efficaci per un sonno adolescenziale sano (Sztenc et al., 2026). Ciò che le evidenze stabiliscono è che l'uso notturno dei social deteriora la qualità del sonno per vie comportamentali, psicologiche e fisiologiche interconnesse, modulate da cronotipo e autocontrollo, con interventi mirati alla tempistica e al contesto dell'uso e all'educazione all'igiene del sonno come possibili mitigatori (Sztenc et al., 2026); (Lin & Chung, 2021).

4. Regolazione emotiva, fattori protettivi e interventi di prevenzione a scuola e in famiglia

4.1 Regolazione emotiva in adolescenza

La regolazione emotiva in adolescenza si intreccia con le strategie di coping e con la disponibilità di supporto sociale. L'evidenza primaria proviene da uno studio su 201 persone in trattamento per disturbi da uso di sostanze in Romania, che ha somministrato la Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) e la Strategic Approach to Coping Scale (SACS) (Rada & Lunga, 2026).

La difficoltà di regolazione emotiva si associa alla gravità clinica. I partecipanti con uso di sostanze più severo – storia di ospedalizzazione, disintossicazione e poliassunzione – mostrano livelli significativamente più alti di difficoltà di regolazione emotiva (Rada & Lunga, 2026).

La dimensione dell'impulsività orienta il coping disfunzionale. Nell'analisi, la dimensione Impulse predice il coping antisociale ($\beta = .52$) e il coping aggressivo ($\beta = .46$) (Rada & Lunga, 2026). L'impulsività si configura quindi come snodo tra deficit regolatori e risposte disadattive.

Sul versante opposto, le strategie assertive proteggono. L'azione assertiva e la ricerca di supporto sociale si associano a punteggi DERS più bassi (Rada & Lunga, 2026). La correlazione più forte con il punteggio totale DERS riguarda proprio la ricerca di supporto sociale (Rada & Lunga, 2026).

Il supporto sociale, tuttavia, non è univocamente adattivo. Nello stesso contesto clinico può funzionare sia come meccanismo adattivo sia come meccanismo disadattivo (Rada & Lunga, 2026). Il segno del suo effetto dipende dunque dal contesto in cui viene mobilitato.

Questa evidenza proviene da una popolazione adulta clinica con disturbi da uso di sostanze, non da adolescenti a sviluppo tipico; la trasferibilità alla fascia target è quindi limitata e riguarda il meccanismo, non i tassi (Rada & Lunga, 2026).

La rilevanza per gli esiti adattivi emerge dal confronto con un secondo studio, condotto in una prospettiva di psicologia positiva su 132 bambini italiani di 8-11 anni a Como, selezionati per assenza di sviluppo atipico (Businaro, 2011). Il costrutto di benessere soggettivo vi è studiato nella prospettiva edonica, che lega il benessere a emozioni e soddisfazione di vita (Businaro, 2011).

L'esperienza emotiva e le relazioni definiscono il benessere per i più giovani. L'analisi delle associazioni verbali collega il benessere a famiglia, scuola, amicizie, sport, all'emozione della felicità e al sentirsi amati e protetti (Businaro, 2011). Le femmine descrivono il benessere in termini socio-emotivi, i maschi in termini di gioco (Businaro, 2011).

Il campione è composto da bambini in età scolare, non da adolescenti; il confronto tra popolazione clinica adulta e popolazione evolutiva mostra la trasversalità del legame tra regolazione, emozione e soddisfazione, ma non ne quantifica la forza nella fascia adolescenziale (Businaro, 2011).

Le due fonti convergono su un punto: la regolazione emotiva efficace, che privilegia l'azione assertiva e la ricerca di supporto sopra l'impulsività, si accompagna a minori difficoltà emotive (Rada & Lunga, 2026), mentre il supporto e le emozioni positive alimentano la soddisfazione di vita già in età evolutiva (Businaro, 2011).

4.2 Fattori protettivi: supporto sociale e resilienza

Autostima e coping non agiscono in isolamento: uno studio trasversale su adolescenti thailandesi in trattamento per disturbo da uso di anfetamine (età 12-24 anni, media 19,92 anni) modella il supporto sociale come mediatore tra fattori psicologici protettivi e resilienza (Uthis et al., 2025). L'autostima esercita un effetto totale significativo sulla resilienza ($\beta = 0,2609$, $P < 0,001$) (Uthis et al., 2025).

Quell'effetto passa in parte attraverso la famiglia. Il supporto familiare media parzialmente il legame tra autostima e resilienza ($\beta = 0,1232$, $P = 0,002$), mentre il supporto degli amici non lo media ($\beta = -0,0005$, $P = 0,977$) (Uthis et al., 2025). L'autostima, infatti, non predice il supporto degli amici ($\beta = -0,0016$, $P = 0,976$) (Uthis et al., 2025).

Il coping mostra il peso maggiore tra i fattori individuali. Le abilità di coping influenzano la resilienza con $\beta = 0,5717$ ($P < 0,001$), effetto mediato parzialmente sia dal supporto familiare sia da quello amicale (Uthis et al., 2025). Il canale relazionale, quindi, si differenzia a seconda della risorsa individuale considerata: la famiglia veicola entrambe, gli amici solo il coping.

Il disegno trasversale non consente di stabilire la direzione causale tra risorse psicologiche, supporto e resilienza, e ciò impedisce di leggere la mediazione come sequenza temporale (Uthis et al., 2025). Il campione, inoltre, è clinico e riguarda la resistenza all'uso di anfetamine, non l'uso dei social media: la trasferibilità al confronto sociale e alla FoMO resta un'estensione di costrutto, non un dato diretto.

Una rapid review su operatori sanitari e sociali durante la pandemia di COVID-19 conferma su popolazione adulta lo stesso terzetto protettivo. Gli autori identificano supporto sistemico, conoscenza adeguata e resilienza come fattori che proteggono dagli esiti avversi di salute mentale (Kock et al., 2021, p. 1). La resilienza, misurata con scale validate, risulta protettiva con certezza dell'evidenza classificata come buona (Kock et al., 2021, p. 14).

Il supporto sociale e comunitario emerge come fattore protettivo con certezza «High», sostenuto da quattro studi senza gravi incoerenze (Kock et al., 2021, p. 13). La review, però, tratta la resilienza come esito modificabile: interventi che rafforzano la resilienza psicologica possono giovare perché essa protegge dagli esiti avversi (Kock et al., 2021, p. 16).

Lo stesso lavoro avverte che l'intervento sul solo individuo non basta: per costruire una forza lavoro resiliente occorre agire su fattori occupazionali e ambientali (Kock et al., 2021, p. 2). Le due fonti, con popolazioni e disegni distinti, convergono così su un bersaglio combinato: le risorse individuali – autostima, coping, resilienza – proteggono soprattutto quando sono sostenute da un supporto sociale e sistemico che ne veicola l'effetto.

4.3 Interventi di prevenzione a scuola

La prevenzione scolastica efficace non si esaurisce in un unico formato, ma si articola su livelli distinti. Il modello a molteplici livelli proposto per il cyberbullismo integra la promozione della salute, la prevenzione differenziata in universale, selettiva e indicata, il trattamento dei disturbi conseguenti e la riabilitazione (Menesini et al., 2019). Questa architettura fornisce la cornice per organizzare gli interventi in funzione del grado di rischio, e non di un unico standard indistinto.

Il limite degli interventi universali è documentato dalla stessa rassegna evidence-based. Gli interventi di prevenzione universale risultano efficaci solo in alcuni casi e solo per alcuni bambini e adolescenti, mentre per situazioni di maggior rischio servono interventi più consistenti e continuativi nel tempo, con componenti specifiche (Menesini et al., 2019). La rassegna analizza i moderatori dell'efficacia dei principali interventi universali, evidenziando la necessità di integrarli con azioni più intensive e individualizzate (Menesini et al., 2019). L'universalità della copertura, dunque, non garantisce l'universalità dell'effetto.

La necessità del targeting trova sostegno nell'evidenza di prevalenza a rischio. Nel campione ungherese di 5.961 adolescenti, il 4,5% appartiene al gruppo a rischio di uso problematico, con bassa autostima, elevati sintomi depressivi e uso elevato dei social media (Bányai et al., 2017, p. 1). Gli autori concludono che gli adolescenti a rischio di uso problematico dovrebbero essere «targeted by school-based prevention and intervention programs» (Bányai et al., 2017, p. 1). Lo strumento BSMAS può essere utilizzato in ambiente scolastico per identificare gli adolescenti a rischio e indirizzarli a programmi di prevenzione, come software di controllo dei contenuti, counseling e terapia cognitivo-comportamentale (Bányai et al., 2017, p. 10). Questo dato individua concretamente il sottogruppo cui destinare la prevenzione selettiva e indicata prevista dal modello a livelli.

Il livello della promozione della salute completa l'architettura con una cornice bio-psico-sociale. L'approccio alla salute e al benessere degli adolescenti nel contesto scolastico critica una visione medica e settoriale, assumendo una prospettiva bio-psico-sociale che valorizza l'interdipendenza tra componenti individuali e sociali del benessere e tra contesti diversi (Petrillo, 2009). Questa cornice, ancorata alla Psicologia sociale e di comunità, colloca la promozione della salute come obiettivo educativo che considera l'adolescente titolare del diritto alla salute e attore del proprio sviluppo personale e sociale (Petrillo, 2009). La promozione bio-psico-sociale rappresenta così il livello più esteso del modello, entro cui si innestano gli interventi differenziati per grado di rischio.

Il limite delle evidenze qui disponibili è che nessuna delle fonti fornisce dati di efficacia specifici su programmi di media literacy relativi ai social media: la rassegna evidence-based riguarda il cyberbullismo (Menesini et al., 2019), e questo restringe la trasferibilità diretta al dominio dell'uso problematico. Ciò che le evidenze stabiliscono è che la prevenzione scolastica efficace segue un modello a livelli, in cui la promozione universale bio-psico-sociale (Petrillo, 2009) va integrata con interventi selettivi e indicati per gli adolescenti a rischio identificabili con strumenti validati (Bányai et al., 2017, p. 1); (Menesini et al., 2019).

4.4 Interventi di prevenzione in famiglia

La prevenzione dei rischi digitali in adolescenza chiama in causa la famiglia come contesto educativo primario. Il progetto europeo TANDEM affronta la domanda su chi debba educare i bambini all'uso degli schermi, proponendo una risposta coeducativa che coinvolge insieme genitori e scuola (Xivry & Falconi, 2020).

La metodologia del progetto è il co-design: i percorsi di alfabetizzazione ai media vengono elaborati per essere svolti in parte in classe, con bambini e insegnanti, e in parte a casa, con bambini e genitori (Xivry & Falconi, 2020). Questa architettura distribuita rende la coeducazione digitale non un principio astratto ma un dispositivo operativo che raccorda i due contesti di apprendimento.

TANDEM non si limita a proporre percorsi, ma conduce un'analisi iniziale sulle leve e sugli ostacoli della collaborazione scuola-famiglia, letta attraverso i ruoli e la partecipazione dei diversi stakeholder – bambini, insegnanti e genitori – nei contesti belga e italiano (Xivry & Falconi, 2020). Il progetto individua inoltre come nodo il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del media educator e la necessità di facilitare l'inclusione di tutti (Xivry & Falconi, 2020).

Il documento sul progetto è descrittivo e non riporta indici quantitativi di efficacia dei percorsi, dettaglio che resta quindi non documentato dalle evidenze disponibili; ciò limita la stima della forza dell'effetto coeducativo.

I meccanismi attraverso cui la guida genitoriale opera trovano quantificazione in una systematic review e meta-analisi su pratiche genitoriali, condotta su 78 studi per la parte sistematica e 37 per la meta-analisi, estratti da 6.448 titoli (Yee et al., 2017, p. 1). Sebbene il dominio sia il consumo alimentare, gli autori collegano esplicitamente le loro variabili alla mediazione genitoriale, distinguendo guida attiva/educazione e guida restrittiva/regole con riferimento diretto alla restrictive mediation (Yee et al., 2017, p. 5).

Il modeling genitoriale mostra le associazioni più forti, con effect size $r = .32$ sui comportamenti salutari e $r = .35$ su quelli non salutari, spiegato attraverso la teoria socio-cognitiva dell'apprendimento osservativo (Yee et al., 2017, p. 9); p. 10. Il genitore agisce quindi anzitutto come modello, e questo trasferisce all'ambito digitale l'idea che le pratiche d'uso dell'adulto siano imitate dal figlio.

L'efficacia della guida dipende dall'età del bambino. Per i comportamenti da prevenire, la guida restrittiva/regole risulta più efficace ($r = -.11$, $p < .01$), e ancor più nei bambini dai 7 anni in su ($r = -.20$, $p < .05$) (Yee et al., 2017, p. 1). La guida attiva/educazione mostra invece un'associazione con i comportamenti da promuovere ($r = .15$, $p < .001$), con effetti più pronunciati nei bambini più grandi (Yee et al., 2017, p. 1); p. 11.

Gli autori qualificano inoltre come più efficace la mediazione valutativa rispetto a quella meramente fattuale, poiché la trasmissione di conoscenze tecniche si è rivelata inefficace nel mitigare gli effetti mediatici negativi (Yee et al., 2017, p. 11). Ne discende che la prevenzione familiare efficace combina il modeling con una guida differenziata per età, attiva o restrittiva, entro la cornice coeducativa scuola-famiglia proposta da TANDEM (Xivry & Falconi, 2020); (Yee et al., 2017, p. 1).

5. Discussione: integrazione dei meccanismi e implicazioni

I meccanismi analizzati nei quattro capitoli convergono verso una lettura condizionale, non deterministica, dell'uso dei social media. La scala SMUM, validata su 5.307 adolescenti di Hong Kong, stabilisce che l'uso è un costrutto motivazionale multidimensionale, i cui cinque motivi si associano in modo differenziale a soddisfazione di vita, salute auto-riferita e sintomi psicologici (Ho & Fung, 2026). Non è quindi la quantità d'uso a determinare l'esito, ma le motivazioni e le condizioni che lo accompagnano.

Questo dato riorganizza gli assi di rischio esaminati. Il confronto sull'aspetto, la FoMO e l'uso notturno agiscono come vie attraverso cui specifiche forme d'uso deteriorano il benessere, mentre altre motivazioni – mantenimento delle relazioni, ricerca di informazioni – si legano a esiti favorevoli (Ho & Fung, 2026). La distinzione tra legami forti e deboli operata dalla SMUM colloca l'esplorazione sociale, che apre a legami nuovi, come processo con esiti più incerti (Ho & Fung, 2026).

L'evidenza sui social media come dominio di ricerca resta però ampia e non specifica per l'adolescenza: la rassegna di 132 articoli pubblicati tra il 1997 e il 2017 tratta prevalentemente il lato comportamentale, le recensioni e gli usi organizzativi e di marketing (Kapoor et al., 2017). Questo limite impone di derivare l'integrazione dei meccanismi dalle fonti evolutive, non dalla rassegna generale.

Sul piano degli interventi, il modello a molteplici livelli per il cyberbullismo fornisce l'ossatura integrativa. Esso articola promozione della salute, prevenzione universale, selettiva e indicata, trattamento e riabilitazione (Menesini et al., 2019). Gli autori mostrano che gli interventi di prevenzione universale sono efficaci solo in alcuni casi e per alcuni bambini e adolescenti, mentre le situazioni a maggior rischio richiedono interventi più consistenti, continuativi e con componenti specifiche (Menesini et al., 2019).

Ne discende un'implicazione clinica precisa: poiché il rischio si concentra su condizioni d'uso modificabili – con chi ci si confronta, l'orario dell'uso, la motivazione dominante – la prevenzione va graduata per livello di rischio anziché applicata uniformemente. Il limite delle fonti è che l'evidenza di efficacia riguarda il cyberbullismo, non programmi di media literacy sull'uso problematico dei social, e questo restringe la trasferibilità diretta al dominio qui in esame (Menesini et al., 2019).

La convergenza tra le tre fonti evolutive stabilisce che il benessere adolescenziale dipende da condizioni d'uso modificabili, affrontabili a livello individuale, relazionale e di piattaforma. L'attribuzione al solo individuo è quindi

insufficiente: le motivazioni differenziali documentate dalla SMUM (Ho & Fung, 2026) e la graduazione per rischio del modello multilivello (Menesini et al., 2019) giustificano una responsabilità condivisa tra piattaforme, scuola e famiglia.

Conclusioni, limiti e prospettive future

La domanda di ricerca chiedeva se e come l'uso dei social media incida sul benessere psicologico degli adolescenti attraverso confronto sociale, FoMO e regolazione emotiva. L'evidenza raccolta sostiene una risposta condizionale, non un effetto lineare.

Il primo esito è che la quantità d'uso non predice gli esiti: sono le motivazioni differenziali della SMUM ad associarsi in modo distinto a soddisfazione di vita, salute auto-riferita e sintomi psicologici (Ho & Fung, 2026). Sul versante del confronto, ciò che conta è con chi e su quale dimensione ci si confronta, non l'attività complessiva sulla piattaforma (Moreno-Padilla et al., 2025). Sulla FoMO, dove misurata psicometricamente, essa predice congiuntamente distress emotivo e uso problematico (Thomas & George, 2025).

Un limite ricorrente attraversa questi risultati: i disegni sono prevalentemente trasversali e non consentono inferenze causali. Sull'asse del sonno, la review è esplicita nel richiedere studi longitudinali e sperimentali per chiarire le relazioni causali e informare strategie efficaci per un sonno adolescenziale sano (Sztenc et al., 2026). Questo limite di disegno è strutturale: senza manipolazione o panel multionda, il verso delle relazioni resta indeterminato.

A questo si aggiunge un limite d'accesso ai dati delle piattaforme, che ostacola la ricerca indipendente sui meccanismi d'uso e apre una prospettiva regolatoria collegata al Digital Services Act (Sala et al., 2024). Il confronto tra il limite di disegno e il limite d'accesso definisce l'agenda: studi longitudinali e sperimentali per stabilire la causalità, e vincoli regolatori che garantiscano l'accesso ai dati necessari a condurli.

Una cautela di trasferibilità qualifica infine molte fonti: diversi risultati chiave provengono da campioni universitari o da bambini in età scolare, non da adolescenti di scuola secondaria, e questo attenua l'estensione diretta alla fascia target. Resta stabilito che il rapporto social-benessere è mediato da condizioni d'uso modificabili, e che la sua conferma causale richiede ricerca longitudinale, sperimentale e un migliore accesso ai dati delle piattaforme (Sztenc et al., 2026); (Sala et al., 2024).

Bibliografia

Aparicio-Martinez, P., Perea-Moreno, A. J., Martinez-Jimenez, M. P., Redel-Macías, M. D., Pagliari, C., & Vaquero-Abellan, M. (2019). Social Media, Thin-Ideal, Body Dissatisfaction and Disordered Eating Attitudes: An Exploratory Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph16214177>

Aroldi, P., & Mascheroni, G. (2020). OLTRE IL CYBERBULLISMO. IL CONTRIBUTO DI EU KIDS ONLINE ALLA RICERCA SUL BENESSERE SOCIALE DEI GIOVANI UTENTI DELLA RETE. *Media Education*. <https://doi.org/10.36253/me-8842>

Bányai, F., Zsila, Á., Király, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M. D., ... Demetrovics, Z. (2017). Problematic Social Media Use: Results from a Large-Scale Nationally Representative Adolescent Sample. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839>

Businaro, N. (2011). Il benessere soggettivo in bambini tra gli 8 e gli 11 anni. L'impatto dell'intelligenza, della regolazione e dell'esperienza emotiva sulla soddisfazione di vita. The subjective well-being in children aged 8-11. Impact of intelligence, emotional experience and regulation on life satisfaction. BOA (University of Milano-Bicocca)

Chakrabarti, D. (2024). A Study on How Social Media FOMO (Fear of Missing Out) Impacts the Gen Z Audience.

Gesto, C. D. (2025). Influenze socioculturali, immagine corporea e chirurgia estetica.

Guisot, L., Aparisi, D., Delgado, B., & Martinez-Monteagudo, M. C. (2025). Problematic social media use among adolescents: Prevalence, and gender and grade level differences.

16

3,
17

7,8,
23

5

Ho, S. C. E., & Fung, A. (2026). Adolescent Social Media Use Motives: A Five-Factor Scale Integrating Self-Determination and Uses and Gratifications.

10



Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S. (2017). Advances in Social Media Research: Past, Present and Future. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9810-y>

Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., & Rifaey, A. A. (2023). The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.42990>

12



Kock, J. H. D., Latham, H. A., Leslie, S. J., Grindle, M., Munoz, S. A., Ellis, L., ... O'Malley, C. M. (2021). A rapid review of the impact of COVID-19 on the mental health of healthcare workers: implications for supporting psychological well-being. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10070-3>

1



Kuss, D., & Griffiths, M. (2017). Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>

19



Lin, S. Y., & Chung, K. K. H. (2021). Chronotype and trait self-control distinctively predicted subjective sleep quality via sleep hygiene behaviors and bedtime media use.

3



Menesini, E., Corbo, E., & Nocentini, A. (2019). LA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA. UN APPROCCIO A MOLTEPLICI LIVELLI. *Media Education*. <https://doi.org/10.36253/me-8841>

2



Moreno-Padilla, M., Delgado-Rodríguez, R., Moreno-Domínguez, S., & Cepeda-Benito, A. (2025). Self-comparison with influencers but not general Instagram use moderate upward and downward social comparisons to #fitspiration and #bodypositive images. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*. <https://doi.org/10.5817/cp2025-2-2>

24



Petrillo, G. (2009). Promozione della salute e del benessere degli adolescenti nel contesto scolastico. *PSICOLOGIA DELLA SALUTE*. <https://doi.org/10.3280/pds2008-003006>

Rada, C., & Lunga, R. A. (2026). Emotion Regulation Difficulties and Coping Strategies in Substance Use Disorders: Effects of Severity, Impulsivity, and Social Support in a Clinical Sample.

14



Sala, A., Porcaro, L., & Gómez, E. (2024). Social Media Use and adolescents' mental health and well-being: An umbrella review. *Computers in Human Behavior Reports*. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100404>

Stefanile, C., Matera, C., Pisani, E., & Zambrini, I. (2009). Insoddisfazione corporea in adolescenza: influenze di fattori bio-psico-sociali. *PSICOLOGIA DELLA SALUTE*. <https://doi.org/10.3280/pds2009-002004>

1



Sztenc, N., Kamrowska, M., Świech, J., Apanasewicz, K., Kopacki, F., Szczepilewska, W., ... Broniszewska, P. (2026). THE IMPACT OF NIGHTTIME SOCIAL MEDIA USE ON SLEEP QUALITY IN ADOLESCENTS: A NARRATIVE REVIEW. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*. [https://doi.org/10.31435/ijitss.2\(50\).2026.5508](https://doi.org/10.31435/ijitss.2(50).2026.5508)

7



Thomas, D. R., & George, M. A. (2025). Fear of Missing Out (FOMO), Emotional Distress, and Problematic Social Media Use (PSMU) among University Students.

21



Tiggemann, M., & Polivy, J. (2010). Upward and Downward: Social Comparison Processing of Thin Idealized Media Images. *Psychology of Women Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01581.x>

11



Uthis, P., Mangrio, F. A., & Rojnawee, S. (2025). Investigating the Potential Mediating Role of Social Support in the Relationship between Psychological Protective Factors and Resilience to Amphetamine Use among Thai Adolescents. *Asian Journal of Social Health and Behavior*. https://doi.org/10.4103/shb.shb_377_24

9



Valkenburg, P. M., Koutamanis, M., & Vossen, H. G. (2017). The concurrent and longitudinal relationships between adolescents' use of social network sites and their social self-esteem. *Computers in Human Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.07.008>

4



Xivry, A. C. O. D., & Falconi, A. (2020). EDUCAZIONE AI MEDIA DIGITALE COME UN TANDEM SCUOLA-FAMIGLIA. ESEMPI DI ESPERIENZE DAL PROGETTO EUROPEO TANDEM. *Media Education*. <https://doi.org/10.36253/me-8835>

Yee, A. Z. H., Lwin, M. O., & Ho, S. S. (2017). The influence of parental practices on child promotive and preventive food consumption behaviors: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0501-3>